

DLBCL / CNSL 新治疗与机制文献监测

近 7 天 PubMed 入库/更新窗口：2026-05-29 至 2026-06-05。官方 ESearch 命中 232 条，筛选 10 篇高相关文献做成 article-per-slide 中文 Frontend Slides。

下载当天 PDF

查看当天归档

CNSL / PCNSL 4 双抗、ASCT、PD-1 与 BTKi 一线组合

BTKi / 联合 3 zanubrutinib、orelabrutinib 与 lenalidomide/R2

ADC / 抗体药物 1 PolaR-ICE 二线挽救和 ASCT 场景

免疫 / CAR-T 2 PD-1 联合与 CAR-T 预测/安全

动态分层 2 CSF ctDNA 与 MYD88 cfDNA 监测

2026-06-05

检索与纳入说明

检索式：((DLBCL OR "diffuse large B-cell lymphoma" OR "large B-cell lymphoma" OR CNSL OR "central nervous system lymphoma" OR "primary CNS lymphoma" OR "secondary CNS lymphoma" OR PCNSL OR SCNSL) AND lymphoma) AND (("2026/05/29"[Date - Entry] : "2026/06/05"[Date - Entry]) OR ("2026/05/29"[Date - Modification] : "2026/06/05"[Date - Modification]))

数据源：NCBI ESearch/EFetch 官方 PubMed XML；本地缓存 pubmed-cache-2026-06-05.json / pubmed-2026-06-05-efetch.xml / pubmed-2026-06-05-selected-esummary.json。

排除：低相关诊断陷阱、非治疗/非机制的普通个案、与 DLBCL/CNSL 关系过弱的条目。

已验证：PMID、题名、期刊、日期、摘要要点

作者观点：仅来自摘要 interpretation / conclusion

我的推断：用于研究设计启示，不作为医疗建议

PMID 42035265

[PubMed 链接](#)

疾病/场景

R/R PCNSL

期刊

American Journal of Hematology

PubMed 日期

2026-06-03 更新

窗口标记

近 7 天新增/更新

glofitamab 治疗 R/R PCNSL：疗效、CNS 穿透与 CSF ctDNA 动态

Multicenter Real-World Analysis of Glofitamab in Relapsed/Refractory Primary CNS Lymphoma: Clinical Activity, CNS Penetration, and ctDNA Dynamics.

结论

16 例 R/R PCNSL 真实世界队列中，glofitamab 单药显示 75% ORR、50% CR，并可在 CSF 中检测到药物；早期 CSF ctDNA 清除与影像反应相关。

glofitamab PCNSL 关键信号



P 人群

16 名成人 R/R PCNSL。

I 干预

glofitamab 单药；部分后续桥接 CAR-T/ASCT。

C 对照

真实世界无正式对照；按分子清除/影像反应观察。

O 结局

ORR/CR、PFS、CSF 药物检测、CSF ctDNA 动态、安全性。

主要内容

- 多中心真实世界研究，16 名成人 R/R PCNSL 接受 glofitamab 单药。
- 中期 ORR 75%，CR 50%；中位 PFS 15.4 个月，OS 尚未达到。
- 60% 患者 CSF 可检测到 glofitamab，CSF/血浆比最高 0.44%。
- 多数不良事件为 1-2 级；2 例 3 级及以上神经毒性经激素恢复，CAR-T 巩固后另有 2 例致死 ICANS。

关键信息

- 这是今天最强的 CNSL 药物进入信号：疗效、CNS 暴露和分子监测同时出现。
- 桥接 CAR-T/ASCT 可能影响长期结局，不能把全部获益归因于 glofitamab 单药。
- CSF ctDNA 比单纯影像更适合进入 PCNSL 早期反应监测设计。

启示

已验证证据：PubMed 摘要记录了样本量、ORR/CR、PFS、CSF 药物检测、ctDNA 动态和神经毒性事件。

论文作者观点：作者认为 glofitamab 在 R/R PCNSL 中显示早期临床活性和可测 CNS 穿透，CSF ctDNA 监测值得前瞻验证。

我的推断：后续 PCNSL 双抗研究应把 CSF 药物浓度、ctDNA 清除和桥接/巩固路径预设为关键分层，而不足只报 ORR。

PMID 42139822

[PubMed 链接](#)

疾病/场景

初治 PCNSL

期刊

European Journal of Cancer

PubMed 日期

2026-06-02 更新

窗口标记

近 7 天新增/更新

波兰真实世界 PCNSL：R-MIV 诱导后 HDC-BET-ASCT 长期疗效与安全性

The long-term efficacy and safety of high-dose chemotherapy with autologous stem cell transplantation in the treatment of primary central nervous system lymphoma: A real-world report from the Polish Lymphoma Research Group.

结论

60 例适合移植的 PCNSL 患者中，HDC-BET-ASCT 在日常实践中可行，4 年 PFS 66%、OS 74%，移植相关死亡 3.3%。

HDC-BET-ASCT 长期结局



P 人群

60 例适合移植的 PCNSL，来自 5 个血液肿瘤中心。

I 干预

R-MIV 诱导 + AT 后 HDC-BET-ASCT。

C 对照

真实世界观察，无随机对照；COVID 期间 vs 非 COVID 期间探索比较。

O 结局

4 年 PFS/OS、复发、移植相关死亡和安全性。

主要内容

- 前瞻性观察研究，5 个血液肿瘤中心共 60 例 PCNSL。
- 策略为 R-MIV 诱导、AT 追加后 HDC-BET-ASCT 巩固。
- 中位随访 51 个月，4 年 PFS 66%，4 年 OS 74%。
- 15 例复发，2 例移植相关死亡；COVID 期间复发更多但 OS/PFS 差异未达显著。

关键信息

- 这不是新药研究，但提供 PCNSL 巩固策略在真实世界的可行性基线。
- 长期随访显示晚期复发仍存在，不能只看 2 年结局。
- 可作为 BTKi/免疫联合一线研究的历史对照和巩固策略参照。

启示

已验证证据：PubMed 摘要记录了 60 例、多中心、4 年 PFS/OS、复发和移植相关死亡数据。

论文作者观点：作者认为 R-MIV 诱导加 HDC-BET-ASCT 在日常实践中可行，并有可接受安全性。

我的推断：PCNSL 新方案若主张替代或减少强化巩固，应至少对照这类长期真实世界 ASCT 基线。

PMID 41672977

PubMed 链接

疾病/场景

新诊断 PCNSL

期刊

Blood Cancer Journal

PubMed 日期

2026-06-03 更新

窗口标记

近 7 天新增/更新

Pen-RMA 一线治疗新诊断 PCNSL：PD-1 联合 HD-MTX/cytarabine 的 II 期研究

Penpulimab combined with rituximab, high-dose methotrexate, and cytarabine (Pen-RMA) in newly diagnosed primary central nervous system lymphoma (PCNSL): a phase 2 trial.

结论

23 例 ITT 分析中，诱导后 ORR 95.7%、CR 91.3%，2 年 PFS 70.7%、OS 75.0%；3 级及以上治疗相关 AE 为 30.4%。

Pen-RMA II 期数据



P 人群

23 例 ITT 新诊断 PCNSL，中位年龄 65 岁。

I 干预

Pen-RMA 诱导，随后按年龄/反应进入 ASCT、WBRT 或 penpulimab 维持。

C 对照

单臂 II 期，无同期对照。

O 结局

ORR/CR、2 年 PFS/OS、AE、CSF ctDNA 清除。

主要内容

- NCT05347641，penpulimab + rituximab + HD-MTX + cytarabine，每 3 周 6 个诱导周期。
- 年轻且达到至少 PR 者进入 ASCT 后 penpulimab 维持；老年或不适合 ASCT 者按反应接受维持或 WBRT。
- 23 例纳入 ITT，中位年龄 65 岁；诱导后 ORR 95.7%，CR 91.3%。
- 中位随访 29.4 个月，PFS/OS 未达到；CSF ctDNA 监测在部分影像 CR/PR 患者中执行。

关键信息

- PCNSL 一线免疫联合仍以单臂 II 期为主，信号强但需要随机或外部验证。
- 方案把 ASCT、WBRT 和 PD-1 维持按年龄/反应分层，实际是路径研究。
- CSF ctDNA 已被放入疗效监测，但摘要未给出充分动态结局关联。

启示

已验证证据：PubMed 摘要记录了试验设计、样本量、ORR/CR、2 年 PFS/OS、AE 和 CSF ctDNA 监测。

论文作者观点：作者认为 Pen-RMA 对 PCNSL 有令人鼓舞的抗肿瘤活性且毒性可管理。

我的推断：这类一线 PCNSL 研究应将年龄、ASCT 资格和分子清除状态作为预设路径，而不只是合并成一个总 ORR。

PMID 41582824

PubMed 链接

疾病/场景

新诊断 PCNSL

期刊

British Journal of Haematology

PubMed 日期

2026-06-02 更新

窗口标记

近 7 天新增/更新

RLZT ± MTX 一线治疗 PCNSL：zanubrutinib 联合来那度胺、利妥昔单抗和替莫唑胺

Zanubrutinib, lenalidomide, rituximab, temozolomide ± methotrexate as first-line treatment for primary central nervous system lymphoma: A prospective, open-label, multicentre clinical trial.

结论

摘要称 RLZT ± MTX 在一线 PCNSL 中显示良好疗效和安全性，尤其适合不能接受强化化疗的老年患者，但 PubMed 摘要未展示具体数值。

RLZT ± MTX 摘要信息边界

研究

前瞻开放多中心

场景

一线 PCNSL

人群

老年/不耐受强化化疗值得关注

缺口

摘要未列 ORR/PFS/毒性数值

P 人群

一线 PCNSL，特别关注不能耐受强化化疗的老年患者。

I 干预

zanubrutinib + lenalidomide + rituximab + temozolomide ± methotrexate。

C 对照

开放标签单臂/非随机框架；摘要未列正式对照。

O 结局

疗效和安全性方向性结论；需全文补充数值。

主要内容

- 前瞻性、开放标签、多中心临床试验。
- 方案包含 zanubrutinib、lenalidomide、rituximab、temozolomide，部分患者加 methotrexate。
- 研究定位是一线 PCNSL，尤其关注不能承受强化化疗的老年患者。
- PubMed 摘要仅给出方向性结论，未列出样本量、ORR、PFS 或毒性率。

关键信息

- PCNSL 一线 BTKi 组合继续扩展，但今天只能把它作为待补全文数据的信号。
- 设计上绕开强化化疗耐受性问题，和 ASCT 巩固路线形成互补。
- 需要核对全文后才能判断该方案是否真正改变一线选择。

启示

已验证证据：PubMed 摘要确认研究类型、方案构成、一线 PCNSL 场景和作者的疗效/安全性方向性表述。

论文作者观点：作者认为 RLZT ± MTX 疗效和安全性良好，尤其适合不能接受强化化疗的老年患者。

我的推断：在全文数据补齐前，不应把该方案写成已证实优于 HD-MTX 或 ASCT 路线，只能作为 PCNSL 一线降强度策略候选。

PMID **41845899**

[PubMed 链接](#)

疾病/场景

R/R DLBCL

期刊

American Journal of Hematology

PubMed 日期

2026-05-29 更新

窗口标记

近 **7 天**新增/更新

PolaR-ICE 二线治疗 R/R DLBCL：polatuzumab 联合 R-ICE 后接 ASCT/维持

Polatuzumab Vedotin Combined With R-ICE (PolaR-ICE) as Second-Line Therapy in Diffuse Large B-Cell Lymphoma.

结论

41 例 R/R DLBCL 中，PolaR-ICE 挽救后 ORR 88%、CR 56%；总体 2 年 PFS 49.9%、OS 75.0%，迟发复发人群 PFS 更好。

PolaR-ICE 二线挽救



P 人群

41 例 R/R DLBCL，主要为二线挽救和移植候选场景。

I 干预

polatuzumab vedotin + R-ICE，部分后接 ASCT 和 Pola 维持。

C 对照

无随机对照；按初治后复发时间分层。

O 结局

ORR/CR、ASCT 进入率、2 年 PFS/OS、安全性。

主要内容

- Pola + R-ICE 挽救治疗，部分患者后续 ASCT 和 Pola 巩固。
- 研究入组早于二线 CAR-T 获批，因此更接近传统挽救/移植场景。
- 41 例中 22 例接受 ASCT，16 例接受 Pola consolidation。
- 早期复发 ≤12 个月患者 2 年 PFS 36.4%，晚期复发 ≥12 个月患者 80.0%。

关键信息

- PolaR-ICE 的价值更可能在晚期复发、CAR-T 不可及或仍以 ASCT 为目标的地区。
- 安全性未见新信号，但血液学和胃肠道 AE 仍是主要负担。
- 摘要明确提示 CAR-T 时代定位需要重新解释。

启示

已验证证据：PubMed 摘要记录了样本量、ORR/CR、ASCT 比例、2 年 PFS/OS 和早晚复发分层结果。

论文作者观点：作者认为 PolaR-ICE 安全有效，可考虑用于晚期复发或 CAR-T 可及性受限场景。

我的推断：未来比较 PolaR-ICE 与 CAR-T/双抗序贯时，应把复发时间和当地 CAR-T 可及性作为核心分层变量。

PMID **41656201**

[PubMed 链接](#)

疾病/场景

R/R DLBCL

期刊

BMC Medicine

PubMed 日期

2026-06-03 更新

窗口标记

近 7 天新增/更新

R2-GemOx-PD1i 治疗 R/R DLBCL：penpulimab 联合来那度胺和 R-GemOx

Penpulimab in combination with lenalidomide and R-GemOx regimen (R2-GemOx-PD1i) in relapsed or refractory diffuse large B-cell lymphoma: a multicenter, single-arm, phase 2 trial.

结论

54 例 R/R DLBCL 单臂 II 期中，总 ORR 66.7%、CRR 57.4%，中位 PFS 30.4 个月；中性粒细胞减少和贫血常见。

R2-GemOx-PD1i



P 人群

54 例 R/R DLBCL，含 ASCT 桥接和非 ASCT 目标亚组。

I 干预

penpulimab + lenalidomide + R-GemOx，随后维持或 ASCT。

C 对照

多中心单臂 II 期，无同期随机对照。

O 结局

诱导后 CRR、ORR、PFS/OS、血液学和免疫相关 AE。

主要内容

- 多中心单臂 II 期，penpulimab + lenalidomide + R-GemOx。
- 38 例无 ASCT 意图，16 例作为 ASCT 桥接。
- 全体 ORR 66.7%，CRR 57.4%；桥接 ASCT 亚组 ORR 75.0%，CRR 68.8%。
- 中性粒细胞减少 66.6%，贫血 59.2%；甲状腺功能减退为最常见免疫相关 AE。

关键信息

- 方案同时扮演治疗和桥接角色，不能只看全体 ORR。
- PD-1 联合化疗/R2 在 R/R DLBCL 中仍是单臂证据，需要对照组确认。
- 免疫相关 AE 和血液学毒性应在后续路径设计中前置管理。

启示

已验证证据：PubMed 摘要记录了试验类型、样本量、ASCT 桥接亚组、ORR/CRR、PFS 和 AE。

论文作者观点：作者认为 R2-GemOx-PD1i 显示令人鼓舞的抗肿瘤活性和可管理毒性。

我的推断：如果作为 CAR-T/ASCT 前桥接，研究终点应加入成功进入巩固治疗比例，而不应只报诱导 CRR。

PMID 41824782

PubMed 链接

疾病/场景

R/R DLBCL

期刊

Blood Advances

PubMed 日期

2026-06-01 更新

窗口标记

近 7 天新增/更新

zanubrutinib + lenalidomide 治疗 R/R DLBCL：I 期剂量递增/扩展研究

Phase 1 study of zanubrutinib plus lenalidomide for patients with relapsed/refractory diffuse large B-cell lymphoma.

结论

66 例 R/R DLBCL 中未见 DLT；RP2D 为 zanubrutinib 160 mg bid + lenalidomide 25 mg qd，RP2D 下 ORR 58%、CR 42%，中位 PFS 5.5 个月。

Zanu + Lena I 期



P 人群

66 例 R/R DLBCL，中位既往 2 线治疗，多数 III/IV 期。

I 干预

zanubrutinib 160 mg bid + lenalidomide 15/20/25 mg qd。

C 对照

I 期剂量递增/扩展，无随机对照。

O 结局

DLT、RP2D、ORR/CR、DOR、PFS、TEAE。

主要内容

- BGB-3111-110，多中心 I 期剂量递增/扩展研究。
- 患者中位既往 2 线治疗，83% 为 III/IV 期，约 67% 为 non-GCB 或 ABC-like。
- 3 级及以上 TEAE 74%，中性粒细胞减少 58%，白细胞减少 29%。
- 治疗相关停药 11%，死亡 3%；中位 DOR 14.9 个月。

关键信息

- BTki + lenalidomide 有活性，但 PFS 和血液学毒性提示不能只看 ORR/CR。
- non-GCB/ABC-like 富集使方案有生物学合理性，但仍需分子亚型验证。
- 适合进入“BTki 组合如何筛患者”的后续监测。

启示

已验证证据：PubMed 摘要记录了剂量、样本量、RP2D、ORR/CR、DOR、PFS 和 3 级及以上 TEAE。

论文作者观点：作者认为 zanubrutinib + lenalidomide 在 R/R DLBCL 中耐受性可接受并有抗肿瘤活性。

我的推断：后续研究应预设 non-GCB/ABC-like、MYD88/CD79B 或免疫微环境分层，否则总体 PFS 可能稀释真正获益人群。

PMID 41555062

[PubMed 链接](#)

疾病/场景
新诊断 DLBCL

期刊
Annals of Hematology

PubMed 日期
2026-06-03 更新

窗口标记
近 7 天新增/更新

SMART 类方案真实世界：BTKi + rituximab + lenalidomide 治疗新诊断 DLBCL

Efficacy of BTK inhibitor combined with rituximab and lenalidomide in newly diagnosed diffuse large B-cell lymphoma: a single-center, retrospective study.

结论

84 例新诊断 DLBCL 回顾性真实世界中，OR2/ZR2 方案中位 PFS 32.4 个月，1 年 PFS 85.3%、2 年 PFS 63.3%，3 年 OS 84.7%。

SMART 类真实世界

样本量
1 年 PFS
2 年 PFS
≥ 3 级 AE



P 人群

84 例新诊断 DLBCL，真实世界 off-label SMART 类治疗。

I 干预

orelabrutinib 或 zanubrutinib + rituximab + lenalidomide。

C 对照

回顾性单中心，无同期标准治疗对照。

O 结局

PFS/OS、ORR、安全性和 3 级及以上 AE。

主要内容

- 单中心、真实世界、off-label 回顾性研究，纳入 2021-2024 年接受 SMART 类方案患者。
- 60.7% 接受 orelabrutinib + rituximab + lenalidomide，39.3% 接受 zanubrutinib + rituximab + lenalidomide。
- 中位随访 13.5 个月；OS 未达到，1/2/3 年 OS 93.4%、85.1%、84.7%。
- 60.7% 出现 3 级及以上 AE，最常见为中性粒细胞减少 54.8%。

关键信息

- 初治 DLBCL 的 BTKi-R2 真实世界信号值得关注，但 off-label 和单中心限制很大。
- 疗效数据需要与 GCB/non-GCB、年龄和合并症分层共同解读。
- 高等级 AE 比例不低，老年患者安全性仍是关键问题。

启示

已验证证据：PubMed 摘要记录了 84 例、OR2/ZR2 构成、PFS/OS 和 3 级及以上 AE。

论文作者观点：作者认为 SMART regimen 可能是 DLBCL 潜在治疗选项，疗效有前景且安全性可接受。

我的推断：该证据更适合提出分层和前瞻验证假设，不足以直接支持常规替代标准一线方案。

PMID **41614438**

[PubMed 链接](#)

疾病/场景

DLBCL

期刊

Human Vaccines & Immunotherapeutics

PubMed 日期

2026-06-02 更新

窗口标记

近 7 天新增/更新

斯洛文尼亚 DLBCL CAR-T 真实世界：预测评分、IL-6 动态与不良事件

CAR T therapy in adult DLBCL patients in Slovenia: Evaluation of predictive scores for outcomes and adverse events.

结论

14 例成人 DLBCL CAR-T 回顾性队列中，反应率 50%、缓解率 29%；EASIX-C Day 0 和 CAR-HEMATOTOX Day -5 的预测价值方向不同。

DLBCL CAR-T 小队列



P 人群

14 名斯洛文尼亚成人 DLBCL CAR-T 患者。

I 干预

CAR-T 治疗前后 IL-6 增幅及 EASIX-C、CAR-HEMATOTOX、IBPS 评分。

C 对照

Day -5 与 Day 0 指标表现比较；无随机对照。

O 结局

反应/缓解、严重细胞减少、预测评分表现和 AE。

主要内容

- 小型真实世界队列，分析 CAR-T 前后 IL-6 增幅和 EASIX-C、CAR-HEMATOTOX、IBPS。
- IL-6 增幅与严重细胞减少出现反向相关，这与研究者预期相反。
- EASIX-C 在 Day 0 计算时预测价值更高，CAR-HEMATOTOX 在 Day -5 更高。
- IBPS 在 Day -5 与 Day 0 比较中结果混合。

关键信息

- 样本小，不适合做确定性结论，但对 CAR-T 前风险评估时间点很有启发。
- IL-6 结果与常规预期不同，应作为待验证现象而非事实规律。
- 日报中更应关注预测工具可否用于治疗前管理，而不是只记录 CAR-T 有效性。

启示

已验证证据：PubMed 摘要记录了样本量、评分工具、IL-6 方向、反应率和缓解率。

论文作者观点：作者认为预测评分有实用价值，但 IL-6 的意外发现需要进一步研究。

我的推断：未来 CAR-T 研究应固定采集 Day -5 和 Day 0 两个时间点，以免错过评分工具最有信息量的窗口。

PMID 42227430

[PubMed 链接](#)

疾病/场景

初治 DLBCL

期刊

Zhongguo Shi Yan Xue Ye Xue Za Zhi

PubMed 日期

2026-06-02 入库

窗口标记

近 7 天新增/更新

初治 DLBCL 血浆 cfDNA MYD88 L265P ddPCR：预后与动态监测价值

[Clinical Value of Detecting MYD88 L265P Mutation in the Plasma of Patients with Treatment-Naive Diffuse Large B-Cell Lymphoma via Droplet Digital PCR].

结论

158 例初治 DLBCL 中，血浆 cfDNA MYD88 L265P 突变率 17.09%，与 non-GCB、III-IV 期、高 IPI、LDH 升高相关，并提示 PFS 较短。

P 人群

158 例初治 DLBCL 血浆样本。

I 干预

ddPCR 检测 cfDNA MYD88 L265P 与 VAF 动态。

C 对照

MYD88 阳性 vs 阴性；VAF $\geq 10\%$ vs $<10\%$ 。

O 结局

临床病理相关性、治疗中反应、PFS/OS 和 VAF 变化。

主要内容

- ddPCR 检测治疗前血浆 cfDNA MYD88 L265P 及 VAF。
- 27/158 例阳性；阳性率在 non-GCB、III-IV 期、IPI 3-5 和 LDH 升高者更高。
- MYD88 L265P 阳性患者 PFS 显著较短，OS 差异未达显著。
- 治疗 2 个周期后，MYD88 L265P VAF 显著下降，提示可用于动态监测。

关键信息

- 这是今天唯一入选的新近入库 DLBCL 液体活检分层研究。
- VAF 与肿瘤负荷相关，但 VAF $\geq 10\%$ 未进一步区分 OS/PFS。
- 可作为 BTKi/免疫联合研究中的 MCD/MYD88 分层监测候选。

启示

已验证证据：PubMed 摘要记录了样本量、突变率、临床相关性、PFS/OS 方向和 VAF 动态下降。

论文作者观点：作者认为 ddPCR 有助于检测 MYD88 L265P，并可用于 DLBCL 动态监测、疗效评价和预后预测。

我的推断：MYD88 cfDNA 可作为研究分层和疗效监测工具候选，但仍需与组织测序、ctDNA 总负荷和治疗方案类型联合验证。

今天的核心信号是 CNSL 药物进入、DLBCL 联合治疗和动态分层一起推进

已验证证据

官方 PubMed 窗口命中 232 条 DLBCL/CNSL 入库或更新记录；本次筛选 10 篇高相关文献，覆盖 PCNSL 双抗/CNS 穿透、PCNSL 一线或巩固方案、DLBCL ADC/BTKi/PD-1 联合、CAR-T 预测和 MYD88 cfDNA。

作者观点

作者普遍认为这些方案或标志物显示可行性和早期疗效信号，但多数研究仍是小样本、单臂、真实世界或回顾性证据，需要前瞻性验证和更长随访。

我的推断

我的推断是，接下来 DLBCL/CNSL 方案设计应把疗效、CNS 暴露、ctDNA/cfDNA 动态、可及性和免疫毒性管理一起前置，而不是只比较单个药物的 ORR。

方案设计启示

优先关注可操作终点：早期分子清除、桥接/巩固路径、CAR-T 前后风险评分、严重血液学毒性和 CNS 穿透；这些比单次影像反应更适合日报追踪。

CNSL 专项启示

PCNSL 今日信号较集中：glofitamab 有可测 CNS 暴露，PD-1/HD-MTX/cytarabine 和 zanubrutinib 组合继续探索一线，ASCT 真实世界数据支持巩固策略但存在移植相关毒性。

下次跟进

后续重点跟进 glofitamab PCNSL 的前瞻验证、PCNSL 一线 BTKi/免疫联合的全文数据、PolaR-ICE 在 CAR-T 可及性不同地区的定位，以及 MYD88 cfDNA 动态是否能进入分层设计。